

Guia para entrevistas de stakeholders

Quem devemos entrevistar?

Grupo 1: Usuários da Linha de Frente (Essenciais)

Estes são os mais importantes, pois usarão o sistema diariamente. As personas principais provavelmente sairão deste grupo.

1. Recepcionista / Atendente da UBS:

- **Quem é:** O profissional que faz o primeiro contato com o paciente, preenche as fichas e organiza a fila.
- **Por que entrevistar:** É o **usuário principal** do seu sistema. Ele vai te dar detalhes riquíssimos sobre as maiores dores do processo atual: a dificuldade de gerenciar prioridades, a perda de fichas, a pressão dos pacientes na fila, as informações que são essenciais no cadastro, etc.

2. Agente Comunitário de Saúde (ACS):

- **Quem é:** O profissional que visita as casas e conhece profundamente a comunidade e os pacientes. Muitas vezes, ele está na UBS para dar suporte ou levar informações.
- **Por que entrevistar:** Ele tem uma visão única sobre as necessidades dos pacientes antes mesmo de eles chegarem à UBS. Pode falar sobre pacientes com dificuldade de locomoção, analfabetos ou com outras necessidades especiais que o sistema precisa considerar.

Grupo 2: Pacientes (A Experiência do Usuário Final)

Entrevistar pacientes é crucial para entender o impacto do sistema na ponta. Tente encontrar perfis diferentes para ter uma visão mais ampla.

1. Paciente Idoso ou com Doença Crônica:

- **Quem é:** Um usuário frequente da UBS, que muitas vezes tem direito a atendimento prioritário.
- **Por que entrevistar:** Ele pode falar sobre a angústia da espera, a dificuldade de entender a ordem da fila e a importância de um atendimento prioritário que realmente funcione. É uma ótima fonte para entender os requisitos de acessibilidade e clareza.

2. Mãe/Pai com Criança Pequena:

- **Quem é:** Outro perfil de paciente que geralmente tem prioridade e urgência.
- **Por que entrevistar:** Pode falar sobre o estresse de esperar em um ambiente cheio com uma criança doente. A percepção de transparência (saber exatamente qual a sua posição na fila) é muito valiosa para este grupo.

3. Paciente Jovem/Adulto (Usuário Ocasional):

- **Quem é:** Alguém que vai à UBS para consultas ou procedimentos pontuais.
- **Por que entrevistar:** Este perfil está mais acostumado com tecnologia (apps de banco, delivery, etc.) e pode ter expectativas diferentes sobre agilidade e digitalização. Pode trazer insights sobre como a tecnologia pode modernizar a experiência.

Grupo 3: Gestão e Profissionais de Saúde (Visão do Processo)

Eles não vão usar o sistema o tempo todo, mas são diretamente impactados por ele e têm uma visão mais ampla do fluxo de trabalho.

1. Coordenador(a) / Gerente da UBS:

- **Quem é:** O responsável pela gestão da unidade de saúde.
- **Por que entrevistar:** Este é um stakeholder com **alto poder de influência**. Ele está preocupado com a eficiência, o tempo médio de espera, a satisfação dos pacientes e a otimização do trabalho da equipe. Pode fornecer insights sobre relatórios gerenciais que o sistema poderia gerar (quantos pacientes atendidos por dia, tempo médio na fila, etc.).

2. Enfermeiro(a) Chefe ou Técnico de Enfermagem (Responsável pela Triagem):

- **Quem é:** O profissional que geralmente chama o paciente da fila de espera para a primeira avaliação (triagem).
- **Por que entrevistar:** Ele é o "próximo passo" depois da recepção. A organização (ou desorganização) da fila impacta diretamente seu trabalho. Ele pode dizer se a ordem de chamada está correta, se as prioridades estão sendo respeitadas e que informação do cadastro inicial é vital para ele.

Ou seja, temos grupos de pessoas que devemos entrevistar.

Grupo 1: Recepcionistas de UBS

Grupo 2: Pacientes

Grupo 3: Administradores de UBS

Modelo de entrevista para o grupo 1

(recepcionistas)

A Entrevista (O Roteiro)

A. Abertura e Aquecimento (5 minutos) - *Criando Confiança*

- **Apresentação:** "Olá, [Nome do Entrevistado]. Meu nome é [Seu Nome]. Muito obrigado por me dar um pouco do seu tempo. Sou estudante do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou desenvolvendo um projeto para a faculdade que busca entender como a tecnologia pode ajudar a melhorar o dia a dia na recepção das Unidades de Saúde."
- **Definir as Regras:** "Quero deixar claro que não existe resposta certa ou errada. Nós não somos especialistas aqui, você é. Estamos aqui para aprender com a sua experiência. Tudo o que conversarmos será usado apenas para o nosso projeto acadêmico."
- **Pedir Permissão para Gravar:** "Para que eu possa prestar total atenção em você, você se importa se eu gravar apenas o áudio da nossa conversa? Isso me ajuda a não me perder nas anotações."
- **Pergunta de Aquecimento:** "Para começar, pode me contar há quanto tempo você trabalha aqui e o que te fez escolher trabalhar na área da saúde?"

B. Exploração da Rotina e Contexto (10 minutos) - *Mapeando o Terreno*

- **A Grande Jornada (The Grand Tour Question):** "Pode me descrever como é um dia normal de trabalho para você? Imagine que eu sou uma sombra, me guie desde o momento em que você chega, abre a recepção, até o final do dia."
 - *Dica de Analista:* Deixe a pessoa falar livremente. Anote os principais verbos e substantivos que ela usa (ex: "pegar a ficha", "carimbar o papel", "procurar o prontuário").
- **Foco nas Ferramentas:** "Quais são as ferramentas, tanto físicas quanto digitais, que você usa para realizar seu trabalho hoje? (ex: fichas de papel, pastas, computador, algum sistema específico, carimbos, telefone)."

- **Mapeando Interações:** "Com quem você mais interage durante o dia? (ex: pacientes, enfermeiros, médicos, outros atendentes)."

C. Aprofundamento nas Dores e Desafios (15 minutos) - *Encontrando o Ouro*

- **Identificando a Fricção:** "Pensando nesse dia a dia que você descreveu, qual é a parte mais difícil, estressante ou frustrante do seu trabalho?"
 - *Técnica Avançada:* Use a **Técnica dos "5 Porquês"**. Se a resposta for "A fila fica confusa", não pare aí. Pergunte:
 1. **"Por que** a fila fica confusa?" (R: "Porque chegam muitos pacientes prioritários ao mesmo tempo que os normais.")
 2. **"Por que** isso é um problema?" (R: "Porque eu não sei quem chamar primeiro e os pacientes começam a reclamar.")
 3. **"Por que** os pacientes reclamam?" (R: "Porque eles acham que a pessoa que chegou depois está passando na frente sem motivo.") ... e assim por diante.
- **Foco em Histórias:** "Pode me contar sobre uma situação específica, um dia que foi particularmente caótico aqui na recepção? O que aconteceu?"
 - *Dica de Analista:* Histórias revelam detalhes, emoções e soluções improvisadas que uma pergunta direta nunca revelaria.
- **Investigando Prioridades:** "Você mencionou o atendimento prioritário. Como funciona essa definição hoje? É visual? Existe alguma regra formal? Já aconteceu de uma prioridade não ser atendida corretamente? O que aconteceu?"
- **O Custo do Erro:** "O que acontece quando uma ficha de papel se perde ou uma informação é anotada errada? Qual o impacto disso?"

D. Exploração de Oportunidades e Visão de Futuro (5 minutos) - *Plantando a Semente da Solução*

- **A Varinha Mágica (The Magic Wand Question):** "Agora, quero que você esqueça qualquer limitação. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse criar o sistema ou a ferramenta perfeita para a sua recepção, como ela seria? O que ela faria para tornar seu dia 10x mais fácil?"
- **Medindo o Sucesso:** "Nessa sua visão ideal, como você saberia que o dia foi bom e eficiente? Qual seria o principal indicador de sucesso para você? (ex: menos reclamações, fila andando rápido, sair no horário)."

E. Encerramento (5 minutos) - *Fechando com Chave de Ouro*

- **A Pergunta Final:** "Existe algo que você acha extremamente importante sobre o seu trabalho que eu não perguntei?"
 - *Dica de Analista:* Essa pergunta é poderosa. Frequentemente, as informações mais valiosas vêm aqui, quando o entrevistado se sente mais à vontade.
- **Agradecimento Sincero:** "Muito obrigado, [Nome do Entrevistado]. Essa conversa foi incrivelmente útil para o nosso projeto. A sua experiência é fundamental para a gente."
- **Próximos Passos:** "Com base nesta e em outras conversas, vamos começar a desenhar um protótipo da solução. Você se importaria se, daqui a algumas semanas, a gente voltasse para te mostrar e pegar sua opinião?"
 - *Dica de Analista:* Isso já prepara o terreno para a fase de testes de usabilidade, transformando o entrevistado em um parceiro do projeto.

Modelo de entrevista para o grupo 2 (Pacientes)

Considerações Éticas Fundamentais:

- **Voluntário e anônimo:** Deixe claro que a participação é voluntária e que nenhuma informação pessoal será coletada ou vinculada a eles.
- **Brevidade:** Respeite o fato de que eles estão ali para uma consulta. A entrevista não deve passar de 10-15 minutos.
- **Empatia:** Se a pessoa parece desconfortável, cansada ou com dor, agradeça e encerre a conversa imediatamente.

Fase 2: A Entrevista (O Roteiro)

A. A Abordagem e o Consentimento (2 minutos) - A Parte Mais Crítica

- **Script de Abordagem:** (Aproxime-se de forma calma e com um sorriso) "Com licença, boa tarde. Meu nome é [Seu Nome], sou estudante universitário e estou fazendo um projeto para melhorar a experiência de atendimento aqui na UBS. Sei que o senhor(a) está aguardando, mas se importaria de responder 3 ou 4 perguntinhas rápidas? Leva menos de 10 minutos. É totalmente anônimo."
- **Se a pessoa concordar, continue:** "Ótimo, muito obrigado! O nosso objetivo é apenas entender como podemos tornar esse tempo de espera mais tranquilo para os pacientes."
- **Pedir Permissão (Opcional):** "Para facilitar, você se importa se eu gravar nosso áudio? Assim presto mais atenção na nossa conversa. Se não quiser, sem problema algum."

B. Reconstruindo a Jornada e as Emoções (7 minutos) - O Coração da Entrevista

- **Pergunta de Partida (Focada na Experiência):** "Pode me contar como foi a sua experiência hoje, desde o momento em que você passou pela porta da UBS?"
 - *Dica de Analista:* Use o termo "experiência" em vez de "processo". Isso convida a pessoa a falar sobre sentimentos, não apenas sobre ações.
- **Aprofundando na Interação Chave:** "E como foi o seu atendimento ali na recepção? Foi rápido? As informações foram claras?"

- **Explorando a Espera (A Dor Principal):** "Enquanto o(a) senhor(a) está aqui aguardando, o que mais passa pela sua cabeça? O que você sente?"
 - *Perguntas de Sondagem (Probes):*
 - "Você tem uma ideia clara de quantas pessoas estão na sua frente?"
 - "Você sabe mais ou menos quanto tempo vai demorar?"
 - "Como essa incerteza faz você se sentir?" (Use palavras como "incerteza", "falta de informação").
- **Investigando a Percepção de Justiça:** "Você consegue entender por que uma pessoa é chamada antes da outra? A regra de prioridade parece clara para você como paciente?"
 - *Dica de Analista:* Esta pergunta investiga a transparência do sistema. A confusão aqui é um forte argumento para um painel visual.
- **Buscando Histórias Passadas:** "Já aconteceu de você vir aqui e a espera ser muito confusa ou estressante? O que tornou aquele dia diferente?"

C. Visão de Futuro e Necessidades (4 minutos) - *Co-criando a Solução*

- **A Pergunta da "Tranquilidade":** "Pensando neste momento de espera, o que poderia ser feito ou que informação você poderia receber que te deixaria mais tranquilo(a) ou seguro(a)?"
 - *Dica de Analista:* Note que não perguntamos "que funcionalidade você quer?". A pergunta é sobre a necessidade emocional ("tranquilidade", "segurança"). A resposta deles (ex: "saber que não fui esquecido", "ver meu nome numa lista") é o que vai se transformar em requisitos para o software.
- **Validando a Direção (Pergunta Sutil):** "Se existisse um painel, como uma TV, mostrando a ordem de chamada e a sua posição na fila, isso ajudaria de alguma forma?"
 - *Por que perguntar isso?* Depois de ter deixado a pessoa falar abertamente, você pode fazer uma pergunta mais direta para validar uma hipótese central do seu projeto. A resposta será muito mais genuína.

Modelo de entrevista para o grupo 3 (Gerentes)

Fase 1: Preparação (O que fazer ANTES da entrevista)

1. **Pesquisa Prévia:** Antes de falar com o(a) coordenador(a), você já conversou com recepcionistas e pacientes. Use isso a seu favor. Comece a conversa já mostrando que entende parte do problema.
 2. **Agendamento Formal:** Diferente dos outros grupos, o ideal é agendar um horário formal. Isso mostra respeito pelo tempo deles. 30 minutos costuma ser o ideal.
 3. **Prepare a Dupla:** O "Entrevistador Principal" deve focar em guiar a conversa estratégica, enquanto o "Anotador" deve registrar não apenas as respostas, mas os termos de negócio e clínicos que eles usam (ex: "fluxo do paciente", "tempo de porta-médico", "glosa", "índice de satisfação").
-

Fase 2: A Entrevista (O Roteiro)

A. Abertura e Alinhamento Estratégico (5 minutos) - *Posicionando-se como Parceiro*

- **Apresentação Profissional:** "Bom dia, [Nome do Entrevistado]. Agradecemos muito pelo seu tempo. Somos estudantes de [Seu Curso] e estamos desenvolvendo um projeto para otimizar o fluxo de atendimento inicial em UBS. Já conversamos com alguns profissionais da recepção e pacientes para entender a perspectiva deles, e agora gostaríamos muito de ouvir sua visão mais estratégica sobre o processo."
- **Definir o Foco:** "Nosso objetivo hoje é entender como o fluxo da recepção impacta o resto da unidade e quais seriam os indicadores de sucesso de uma melhoria nesse processo, do ponto de vista da gestão (ou do cuidado clínico)."
- **Pedir Permissão para Gravar:** "Para garantir que não vamos perder nenhum detalhe importante da sua análise, você se importa se gravarmos o áudio da conversa?"

B. Visão Estratégica e Objetivos Atuais (7 minutos) - *Entendendo o "Norte"*

- **Para o(a) Coordenador(a) / Gerente:**
 - "Quais são hoje os principais desafios na gestão desta UBS? Onde estão suas maiores prioridades?"
 - "Quando você pensa em 'eficiência' ou 'qualidade de atendimento', o que vem à sua mente? Como você mede isso hoje, mesmo que informalmente?"
- **Para o(a) Enfermeiro(a) Chefe / de Triage:**
 - "Do ponto de vista clínico, qual é o maior gargalo no fluxo do paciente, desde a chegada até a consulta?"
 - "Qual é a sua principal preocupação em relação à segurança e qualidade do atendimento na fase inicial, antes mesmo do paciente chegar à triagem?"

C. Mapeamento do Impacto Sistêmico (10 minutos) - *Conectando os Pontos*

- **Pergunta-Chave Geral:** "De que forma a maneira como a recepção funciona hoje (com fichas manuais, organização da fila, etc.) impacta o trabalho da sua equipe de enfermagem e dos médicos?"
- **Investigando a Cascata de Problemas:**
 - "Já aconteceu de um erro no cadastro inicial na recepção causar problemas mais tarde, na triagem ou na consulta?" (Ex: paciente errado, motivo da visita incorreto).
 - "Como a falta de clareza sobre a ordem da fila e as prioridades na recepção afeta o ritmo da equipe de triagem?"
 - "Você recebe reclamações de pacientes sobre a espera? Como isso impacta o ambiente de trabalho e o tempo da sua equipe?"
- **Foco em Informação Crítica:** "Que informação, se fosse coletada de forma correta e clara na recepção, tornaria o trabalho da triagem e da consulta muito mais ágil e seguro?"

D. Métricas, Dados e Visão de Sucesso (5 minutos) - *Falando a Língua da Gestão*

- **A Pergunta de 1 Milhão de Dólares:** "Imagine que implementamos um sistema digital na recepção que organiza a fila, gerencia prioridades e exibe um painel para os pacientes. Daqui a 6 meses, **como você saberia que o projeto foi um sucesso?** Quais resultados você gostaria de ver?"
 - *Dica de Analista:* Espere respostas como: "Redução no número de reclamações de pacientes", "Diminuição do tempo médio de espera", "Feedback positivo da equipe da recepção", "Maior

agilidade na triagem". **Anote isso!** Essas são as métricas de sucesso do seu projeto.

- **Necessidades de Dados:** "Que tipo de informação ou relatório sobre o fluxo de pacientes seria útil para você tomar melhores decisões na gestão da unidade?" (Ex: horários de pico, número de atendimentos por dia, tempo médio de espera por prioridade).

E. Encerramento e Próximos Passos (3 minutos) - *Garantindo o Apoio*

- **A Pergunta Final de Alinhamento:** "Considerando o que conversamos, existe algum outro processo, regra ou stakeholder (como a Secretaria de Saúde, por exemplo) que você acha que deveríamos considerar para que um projeto como este tenha sucesso aqui?"
- **Agradecimento e Validação:** "Essa visão gerencial/clínica é fundamental e nos ajuda a garantir que não estamos apenas criando 'mais um programa', mas uma ferramenta que realmente gera valor. Muito obrigado pelo seu tempo."
- **Manter o Canal Aberto:** "À medida que avançarmos, gostaríamos de apresentar um protótipo para o(a) senhor(a). Seria uma forma de garantir que estamos no caminho certo para atender às necessidades da unidade."